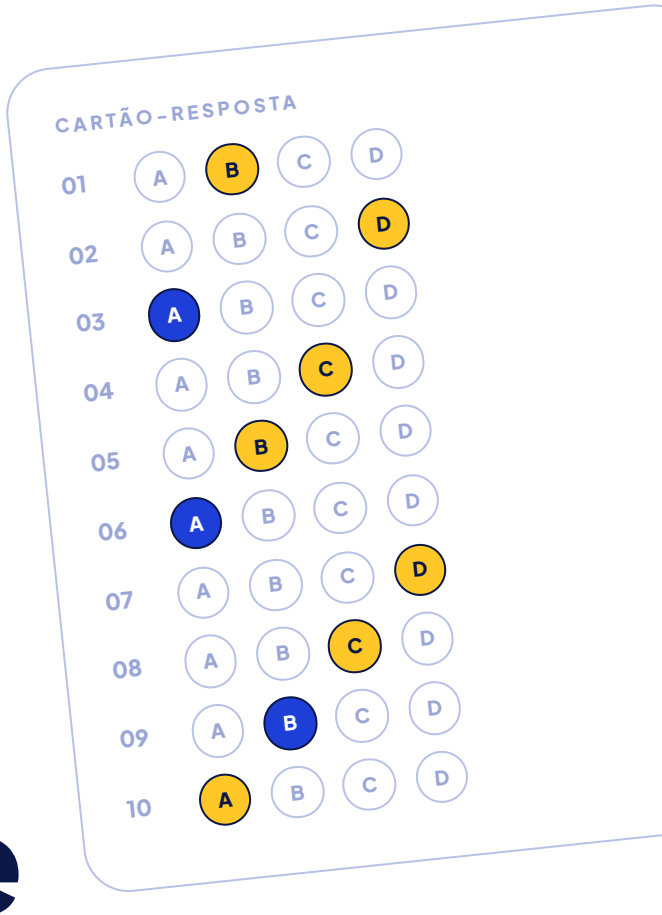
caneta na mão

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA DE BIRIGUI-SP



AMOSTRA GRÁTIS

Experimente antes de comprar

Um assunto completo da apostila + as questões reais desse assunto com gabarito comentado

Agente Comunitário de Saúde | **Prefeitura de Birigui-SP**

AMOSTRA DO KIT AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1 assunto completo de Específicos	**8** questões reais da banca ACCESS	**100%** com gabarito comentado

Edital 220/2026 · Banca Instituto ACCESS
Material independente

DATA DA PROVA
14/02/2027

O que tem nesta amostra

1. **O sumário da apostila**, para você ver tudo o que o kit cobre: Português, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Específicos, na ordem do edital.

2. **Um assunto completo**: Visita domiciliar, risco, vulnerabilidade e programas sociais, exatamente como está na apostila, com o quadro “O que cai e quanto cai”, as tabelas, “Como a ACCESS cobra” e as caixas “Meu resumo” e “Meus erros”.

3. **As 8 questões reais** desse assunto, tiradas de provas de ACS da banca Instituto ACCESS (e de reforço da mesma banca), e o **gabarito comentado** de cada uma.

Faça as questões depois de ler a teoria e corrija pelo gabarito. Se gostar do jeito de estudar, o kit completo tem 40 assuntos e 325 questões.

caneta na mão

SUMÁRIO

O que tem neste volume

Conteúdo do edital	O que vai cair, item por item, com o assunto da apostila onde ele está	4
Como usar	O ciclo de cada assunto, as revisões e a ordem de estudo	7
Parte 1 · Língua Portuguesa	11 assuntos · Interpretação, gramática, fonologia e ortografia, do que mais cai para o que menos cai.	9
Parte 2 · Raciocínio Lógico e Matemático	11 assuntos · Lógica, sequências, porcentagem e toda a matemática do edital, com exemplos resolvidos.	47
Parte 3 · Conhecimentos Gerais	9 assuntos · Birigui, São Paulo, Brasil e mundo: atualidades até outubro de 2026 e história.	73
Parte 4 · Conhecimentos Específicos	9 assuntos · SUS, Atenção Primária, Lei 11.350, território, visita domiciliar, educação em saúde, vacinas, vigilância e registros.	93

40 assuntos
cobrindo o edital inteiro

7 provas de ACS
da banca ACCESS (2023–2026)

Questões resolvidas
passo a passo, uma por assunto

Meu resumo e Meus erros
em todos os assuntos

Use junto com o **Caderno de Questões** (325 questões reais da ACCESS, na mesma ordem desta apostila, com gabarito comentado). Os números do "Agora pratique" são as questões do Caderno.

Material independente, sem vínculo com a Prefeitura de Birigui ou com o Instituto ACCESS. Confira sempre o edital oficial e suas retificações. Atualidades até outubro de 2026.

05 Visita domiciliar, risco, vulnerabilidade e programas sociais

O QUE CAI E QUANTO CAI

No edital: itens 2.3 a 2.5 — visita domiciliar; identificação de situações de risco e vulnerabilidade; orientação sobre acesso aos serviços de saúde.

Nas provas da ACCESS: [redacted] **caiu em 86% das provas** (6 de 7 provas de ACS analisadas) · 8 questões no Caderno

O que mais cai dentro do assunto: visita domiciliar (planejar, realizar, registrar, comunicar) · riscos e vulnerabilidade · **programas sociais** (Bolsa Família) · orientar o acesso à UBS.

1. A visita domiciliar, passo a passo

Momento	O que fazer
Antes	Rever o **cadastro** da família e os **registros das visitas anteriores**; definir o **objetivo** da visita; levar o material (fichas, tablet, folhetos)
Durante	Apresentar-se, pedir licença, respeitar o espaço, a cultura e as crenças da família; ouvir com atenção; observar a casa e o entorno; orientar em linguagem simples; atualizar o cadastro
Depois	**Registrar** o que foi visto e feito; **comunicar à equipe** as situações de risco; marcar retorno conforme a necessidade

- Ao entrar na casa, o ACS entra na história, nos costumes e nas regras daquela família. A habilidade mais importante é a **sensibilidade** para criar vínculo de confiança, sem confundir a relação pessoal com o papel profissional.
- A frequência das visitas segue o **risco**: gestantes, recém-nascidos e crianças pequenas, idosos acamados, pessoas com doença crônica descompensada, famílias vulneráveis e faltosos vêm primeiro.
- Visita rápida e superficial, sem registro, ou só "quando a família pedir", está errada.

2. Risco e vulnerabilidade

Tipo	Exemplos
Risco à saúde	Gestante sem pré-natal, criança com vacina atrasada ou desnutrida, idoso acamado ou que cai, hipertenso/diabético sem acompanhamento, tosse há mais de 3 semanas
Risco ambiental	Lixo, água parada, esgoto a céu aberto, uso incorreto de agrotóxicos, animais soltos
Vulnerabilidade social	Desemprego, baixa renda, analfabetismo, uso de álcool e drogas, moradia precária, muitas pessoas por cômodo
Violência e negligência	Sinais de violência contra criança, mulher ou idoso: o ACS **comunica à equipe**, que faz a notificação e aciona a rede (Conselho Tutelar, CRAS/CREAS)

3. Orientar o acesso e os programas sociais

- O ACS explica como a UBS funciona: horários, acolhimento, agendamento, demanda espontânea, vacinação, grupos; e **encaminha** as pessoas aos serviços sempre que necessário.
- Ele identifica famílias vulneráveis, **orienta sobre os critérios** e encaminha à assistência social (CRAS, **Cadastro Único**). A inscrição em si é feita pelo setor responsável, não pelo ACS.

Programa	Pontos que caem
Bolsa Família (Lei 14.601/2023)	Família inscrita no Cadastro Único com renda de até **R$ 218 por pessoa**; benefício mínimo de R$ 600. Condicionalidades de **saúde**: pré-natal das gestantes, **calendário vacinal** e acompanhamento do **estado nutricional** das crianças menores de 7 anos. Educação: frequência escolar mínima
BPC (LOAS)	1 salário mínimo para idoso a partir de 65 anos ou pessoa com deficiência, com renda familiar por pessoa de até 1/4 do salário mínimo

CRAS · PAIF · SCFV	Porta de entrada da assistência social · acompanhamento das famílias · convivência e fortalecimento de vínculos
PETI	Erradicação do trabalho infantil (CREAS): inserir as crianças no SCFV e as famílias no PAIF

◎ COMO A ACCESS COBRA

- Caso prático de visita: a conduta certa sempre junta **atualizar, orientar e comunicar à equipe**.
- O que fazer antes da visita (cadastro, visitas anteriores, objetivo).
- Bolsa Família: critério de renda e condicionalidades de saúde.

Questão 290 do Caderno · ACCESS · Planaltina/GO · Agente Comunitário de Saúde · 2026

As visitas domiciliares representam uma das principais ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), permitindo conhecer a realidade das famílias, identificar riscos e fortalecer o vínculo com o território. Em determinado setor, a equipe percebe aumento de situações de vulnerabilidade social e solicita ao ACS que intensifique o monitoramento das famílias prioritárias, registrando informações relevantes para o planejamento das ações. Com base nas atribuições do Agente Comunitário de Saúde durante a visita domiciliar, escolha, dentre as alternativas apresentadas, a única que está correta.

A. Realizar a visita apenas quando houver demanda espontânea da família, evitando registros formais para não expor informações sensíveis.
B. Priorizar visitas rápidas e superficiais para aumentar o número de domicílios atendidos, mesmo que sem coleta detalhada de informações.
C. Realizar a visita com objetivo definido, registrar informações essenciais sobre a família e comunicar à equipe situações de risco identificadas.
D. Limitar-se a observar o ambiente domiciliar sem realizar orientações, pois a educação em saúde deve ser conduzida exclusivamente na unidade.

Resolvendo passo a passo

1. A: só visitar quando a família pede e sem registrar → errado (a visita é regular e registrada).
2. B: visitas rápidas e superficiais só para aumentar o número → errado.
3. C: visita com objetivo, registro das informações e comunicação dos riscos à equipe → **correta**.
4. D: o ACS orienta durante a visita; educação em saúde não é só na unidade → errado.

Resposta: C

✎ MEU RESUMO (com minhas palavras — só o que eu esqueceria)

× MEUS ERROS (anote toda questão que errar e a regra certa)

Questão nº	Por que errei	Regra certa

▶ AGORA PRATIQUE Caderno de Questões · faça da 288 à 295 (8 questões)

Provas de Agente Comunitário de Saúde (ACCESS) · 288 a 295

☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295

Marque ✓ se acertou e × se errou (acerto no chute = ×). Corrija pelo gabarito comentado no fim do Caderno.

05 Visita domiciliar, risco, vulnerabilidade e programas sociais

questões 288–295
caiu em 86% das provas

288 Planaltina/GO · 2026

Os programas sociais e de transferência de renda desempenham papel fundamental na melhoria das condições de vida das famílias acompanhadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Durante uma ação intersetorial, a equipe discute a necessidade de identificar famílias em vulnerabilidade e orientar sobre o acesso a benefícios, reforçando o papel do ACS como articulador entre saúde e proteção social. Considerando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde vinculadas aos programas sociais, avalie os itens apresentados. Agora, selecione a alternativa correta.

I.O ACS deve identificar famílias em situação de vulnerabilidade social e comunicar à equipe, contribuindo para o encaminhamento adequado a programas sociais.

II.É atribuição do ACS realizar a inscrição direta das famílias em programas sociais, preenchendo formulários e validando informações oficiais.

III.O ACS pode orientar sobre critérios gerais de acesso aos programas sociais, bem como sobre os serviços públicos disponíveis no território.

IV.O ACS deve atuar de forma integrada com outros setores, como assistência social, educação e segurança alimentar, sempre que necessário para apoiar as famílias. Após a análise dos itens, selecione a alternativa correta.

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
D) Apenas os itens II e III estão corretos.

289 Planaltina/GO · 2026

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha papel fundamental na identificação de necessidades do território, na comunicação entre comunidade e equipe de saúde e na promoção de ações educativas. Em uma atividade de supervisão, a equipe busca reforçar que o ACS deve reconhecer situações de vulnerabilidade e agir de forma articulada com os profissionais da unidade. Considerando essas atribuições, complete corretamente a lacuna a seguir e marque a única alternativa correta: Durante a visita domiciliar, cabe ao ACS _____, garantindo que a equipe tenha acesso às informações necessárias para planejar ações de cuidado no território.

A) Conduzir intervenções clínicas de baixa complexidade sempre que identificar necessidade no domicílio.
B) Identificar fatores de risco e comunicar imediatamente à equipe situações que exijam maior atenção.
C) Registrar somente dados administrativos, deixando aspectos de saúde exclusivamente para profissionais técnicos.
D) Restringir-se à observação silenciosa, informando apenas quando solicitado explicitamente pela família.

290 Planaltina/GO · 2026

As visitas domiciliares representam uma das principais ferramentas de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), permitindo conhecer a realidade das famílias, identificar riscos e fortalecer o vínculo com o território. Em determinado setor, a equipe percebe aumento de situações de vulnerabilidade social e solicita ao ACS que intensifique o monitoramento das famílias prioritárias, registrando informações relevantes para o planejamento das ações. Com base nas atribuições do Agente Comunitário de Saúde durante a visita domiciliar, escolha, dentre as alternativas apresentadas, a única que está correta.

A) Realizar a visita apenas quando houver demanda espontânea da família, evitando registros formais para não expor informações sensíveis.
B) Priorizar visitas rápidas e superficiais para aumentar o número de domicílios atendidos, mesmo que sem coleta detalhada de informações.
C) Realizar a visita com objetivo definido, registrar informações essenciais sobre a família e comunicar à equipe situações de risco identificadas.
D) Limitar-se a observar o ambiente domiciliar sem realizar orientações, pois a educação em saúde deve ser conduzida exclusivamente na unidade.

291 Volta Grande/MG · 2024

Uma das principais atividades do agente comunitário de saúde são as visitas domiciliares. Através delas, é possível:

I.Ensinar medidas de prevenção de doenças e promoção à saúde, como os cuidados de higiene com o corpo, no preparo dos alimentos, com a água de beber e com a casa, incluindo o seu entorno.

II.Conhecer as condições de moradia e de seu entorno, de trabalho, os hábitos, as crenças e os costumes.

III.Divulgar e explicar o funcionamento do serviço de saúde e quais as atividades disponíveis.

IV.Conhecer os principais problemas de saúde dos moradores da comunidade. Fonte: Ministério da Saúde. O trabalho do agente comunitário de saúde. Brasília. 2009. Estão corretas as afirmativas:

A) I e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

292 Domingos Martins/ES · 2023

É correto afirmar que o ACS deve realizar as ações listadas nas alternativas a seguir, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

A) identificar áreas e situações de risco individual e coletivo
B) encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário
C) orientar as pessoas, de acordo com a sua sensibilidade
D) acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados

293 Domingos Martins/ES · 2023

É necessário considerar condições que aumentam o risco externo de as pessoas adoecerem, como os listados nas alternativas a seguir, ***à exceção de uma***. Assinale-a.

A) desemprego
B) uso incorreto de venenos na lavoura
C) uso inadequado de medicamentos prescritos
D) relacionamentos afetivos interrompidos

294 Domingos Martins/ES · 2023

A respeito da visita domiciliar do ACS, analise as afirmativas a seguir:

I. Ao entrar na casa de uma família, o ACS entra não somente no espaço físico, mas em tudo o que esse espaço representa. Nessa casa vive uma família, com seus códigos de sobrevivências, suas crenças, sua cultura e sua própria história.

II. A sensibilidade/capacidade de compreender o momento certo e a maneira adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança é uma das habilidades mais importantes do ACS. Isso ajudará a construir o vínculo necessário ao desenvolvimento das ações de promoção, prevenção, controle, cura e recuperação.

III. É importante que o ACS estabeleça um bom vínculo com a família, mas saiba dissociar a sua relação pessoal do seu papel como Agente Comunitário de Saúde. Assinale

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

295 Cataguases/MG · 2024

O trabalho infantil é uma realidade triste que ainda persiste no Brasil, violando os direitos fundamentais de milhares de crianças e adolescentes. Mesmo sendo condenado pela maioria dos países e fiscalizado por agências internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para sua erradicação, a exploração do trabalho infantil continua a roubar a infância e comprometer o desenvolvimento saudável desses jovens. (Disponível em: https://institutoc.org.br) Quanto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), no âmbito municipal da Proteção Social Especial, nos Creas, no que tange às ações de enfrentamento ao trabalho infantil, analise as afirmativas a seguir:

I. Encaminhar e inserir as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no SCFV, em grupo de faixa etária correspondente e/ou em outras políticas e serviços existentes na região.

II. Encaminhar os adolescentes de 16 a 18 anos para o mercado de trabalho de forma segura, conforme legislação.

III. Incluir as famílias no Paif, em diversas ações, como acolhida, ações particularizadas, encaminhamentos, oficinas, ações comunitárias, entre outras. Assinale

A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questões de outros assuntos: disponíveis no kit completo.

Gabarito comentado

288. C I, III e IV corretas: identificar vulnerabilidade e comunicar, orientar sobre critérios dos programas, atuar com outros setores. II errada: a inscrição é feita pelo setor responsável (Cadastro Único na assistência social), não pelo ACS.

289. B Na visita, o ACS identifica fatores de risco e comunica imediatamente à equipe o que exige atenção. Ele não faz intervenções clínicas.

290. C Visita com objetivo definido, registro das informações essenciais e comunicação dos riscos à equipe. Visita rápida demais, sem registro ou sem orientação está errada.

291. D As quatro estão corretas: na visita o ACS ensina prevenção, conhece moradia e costumes, divulga os serviços e conhece os problemas de saúde.

292. C O ACS orienta com base no que a equipe e os protocolos definem, não 'de acordo com a sua sensibilidade'. As demais são ações do ACS.

293. D Desemprego, uso incorreto de agrotóxicos e de medicamentos são riscos externos para adoecer. A banca considerou 'relacionamentos afetivos interrompidos' fora dessa lista.

294. D As três estão corretas: a casa representa a história e a cultura da família, o ACS precisa de sensibilidade para criar vínculo e deve separar a relação pessoal do papel profissional.

295. D I e III corretas: inserir no SCFV e incluir a família no PAIF. II errada: o PETI combate o trabalho infantil; encaminhar ao trabalho não é ação do programa (a aprendizagem é regra própria, a partir de 14 anos).

Gostou? Este é o kit completo

- **Apostila completa** (119 páginas): os 40 assuntos do edital, com o que mais cai na banca ACCESS e questões resolvidas passo a passo.
- **Caderno de Questões**: 325 questões reais, separadas por assunto, na mesma ordem da apostila, todas com gabarito comentado.
- **Bônus**: edital verticalizado em checklist + roteiro da última semana e do dia da prova.
- Feito para o cargo **Agente Comunitário de Saúde** da Prefeitura de Birigui, com a Lei 11.350, SUS, vacinas e vigilância. Acesse pelo celular, tablet ou imprima.

Prova em 14/02/2027. Garanta o seu material pelo link onde você baixou esta amostra.